

Prolapsus des organes pelviens

Information pour le patient · Quand les organes pelviens descendent et causent un renflement ou une pression **WARWIKI**

Le prolapsus des organes pelviens (POP) survient lorsque les structures de soutien autour des organes pelviens — la vessie, l'utérus ou le rectum — s'affaiblissent, et qu'un ou plusieurs organes appuient dans le vagin ou en sortent. Cela provoque un **renflement ou une sensation de pression**. C'est très fréquent, ce n'est **ni dangereux ni cancéreux**, et il existe de bonnes options allant des exercices à un dispositif de soutien ou à la chirurgie.

À propos de cette affection

Le prolapsus est nommé selon la paroi qui descend :

- **Paroi antérieure** (vessie) — une cystocèle
- **Paroi postérieure** (rectum) — une rectocèle
- **Sommet** (utérus, ou le fond vaginal après une hystérectomie)

Symptômes fréquents :

- Un **renflement ou une masse** visible ou palpable à l'orifice vaginal
- Une **pression ou lourdeur pelvienne**, souvent accentuée en fin de journée ou à l'effort
- Difficulté à vider complètement la vessie ou l'intestin ; parfois, appuyer sur le renflement pour y parvenir (« attelle digitale »)

Causes

Tout ce qui sollicite ou affaiblit le soutien pelvien : **grossesse et accouchement**, ménopause et vieillissement, efforts chroniques (constipation ou toux), port de charges lourdes, chirurgie pelvienne antérieure, surpoids et prédisposition familiale.

COMPRENDRE LES TERMES

Prolapsus

Descente d'un organe pelvien hors de sa position normale.

Cystocèle

Renflement de la vessie dans la paroi vaginale antérieure.

Rectocèle

Renflement du rectum dans la paroi vaginale postérieure.

Fond vaginal

Le sommet du vagin, qui peut descendre après une hystérectomie.

Pessaire

Dispositif de soutien amovible placé dans le vagin pour maintenir les organes en place.

Attelle digitale

Appuyer sur le renflement pour aider à vider la vessie ou l'intestin.

Plancher pelvien

Les muscles qui soutiennent les organes pelviens.

POP-Q

L'examen utilisé pour mesurer l'étendue du prolapsus.

EST-CE QUE JE DOIS LE TRAITER ? Seulement si cela vous gêne. Le prolapsus n'est pas dangereux ; si les symptômes sont légers, vous pouvez simplement surveiller. Lorsqu'il affecte votre confort ou votre quotidien, vous choisissez parmi plusieurs options efficaces — il n'y a pas de réponse unique, et vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Comment on le diagnostique

- Un **examen pelvien**, souvent debout ou en poussant, pour voir quelles parois descendent et de combien
- Un bilan des symptômes vésicaux et intestinaux
- Parfois un **bilan urodynamique** si vous avez aussi des fuites urinaires

Comment on le traite (étape par étape)

- 1 **Surveillance simple** si le prolapsus ne vous dérange pas, avec mesures préventives (traiter la constipation, éviter les charges lourdes, contrôler le poids).
- 2 **Exercices du plancher pelvien / kinésithérapie** pour les prolapsus légers.
- 3 Un **pessaire** — un dispositif de soutien amovible qui soulage le renflement sans chirurgie.
- 4 **Chirurgie** — une réparation pour restaurer le soutien, une fermeture vaginale (colpocléisis) ou une suspension. Chaque option dispose de sa propre fiche.

Vivre avec un prolapsus

- Gardez les selles molles et **évit**ez de **pousser** ; ne soulevez pas de charges au-delà de ce que votre équipe soignante conseille.
- Faites vos exercices du plancher pelvien ; gérez la toux et votre poids.
- Un pessaire peut être une solution à long terme, pas seulement provisoire.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Vous **ne pouvez pas uriner** ou aller à la selle
- Le renflement devient **douloureux, saigne ou est à vif / ulcéré**
- De la fièvre, ou vous ne pouvez pas repousser le renflement

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Le prolapsus est une descente fréquente et non dangereuse des organes pelviens, qui provoque un renflement ou une pression.
2. Traitez-le seulement s'il vous gêne — les options vont de la surveillance et des exercices au pessaire ou à la chirurgie.
3. Évitez les efforts et les charges lourdes. Consultez si vous ne pouvez pas vider votre vessie ou votre intestin, ou si le renflement devient douloureux ou à vif.